



TrazaRed HUV

LUZ ANGELA CARABALI MULATO
LAURA DANIELA ASTUDILLO ORTEGA
NICOLAS ZAPATA OBANDO
DAVID ORTEGA QUINTERO



Contexto

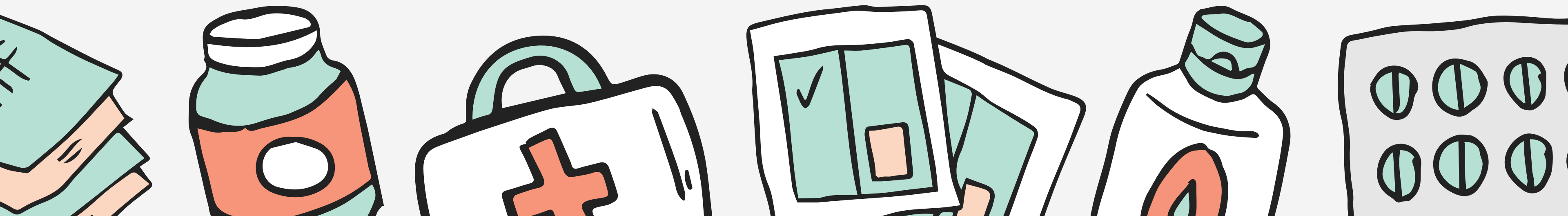
El Hospital Universitario del Valle "Evaristo García" es la institución de mayor complejidad del suroccidente colombiano, referente para Cauca, Chocó, Huila, Nariño y Putumayo. El proceso analizado es la remisión y el traslado de pacientes hacia y desde otras instituciones, coordinado en teoría por la oficina de referencia y contrarreferencia y el CRU. Este proceso es crítico porque el HUV opera al límite de su capacidad, con ocupación de urgencias del 130%.



El problema identificado

El HUV no cuenta con un proceso trazable ni verificable para gestionar la remisión y el traslado de pacientes. La gestión se hace caso a caso, sin registro único que confirme qué instituciones fueron contactadas, si tenían disponibilidad, o si existía convenio vigente. Esto se confirmó en la sentencia T-573-23 de la Corte Constitucional, donde una EPS afirmó haber gestionado un traslado con 13 IPS incluido el HUV y el hospital certificó que nunca recibió esa solicitud.

Dominio: Gestión hospitalaria.



Consecuencias y afectados

Consecuencias

- Pacientes en espera sin certeza de si su caso está siendo gestionado
- Decisiones médicas y administrativas sin información confiable
- Traslados fallidos o demoras evitables
- Sobreocupación crónica del HUV (130% en urgencias)
- Consecuencias legales concretas, como el caso que escaló hasta la Corte Constitucional

Actores afectados



- El paciente, cuya atención depende de que el traslado se gestione a tiempo
- El personal del HUV, que decide sin información confiable
- El hospital como institución, que absorbe demanda que no le corresponde y enfrenta procesos legales
- Las EPS e IPS de la red, sin mecanismo confiable para verificar el estado de una remisión

Diagrama actores involucrados

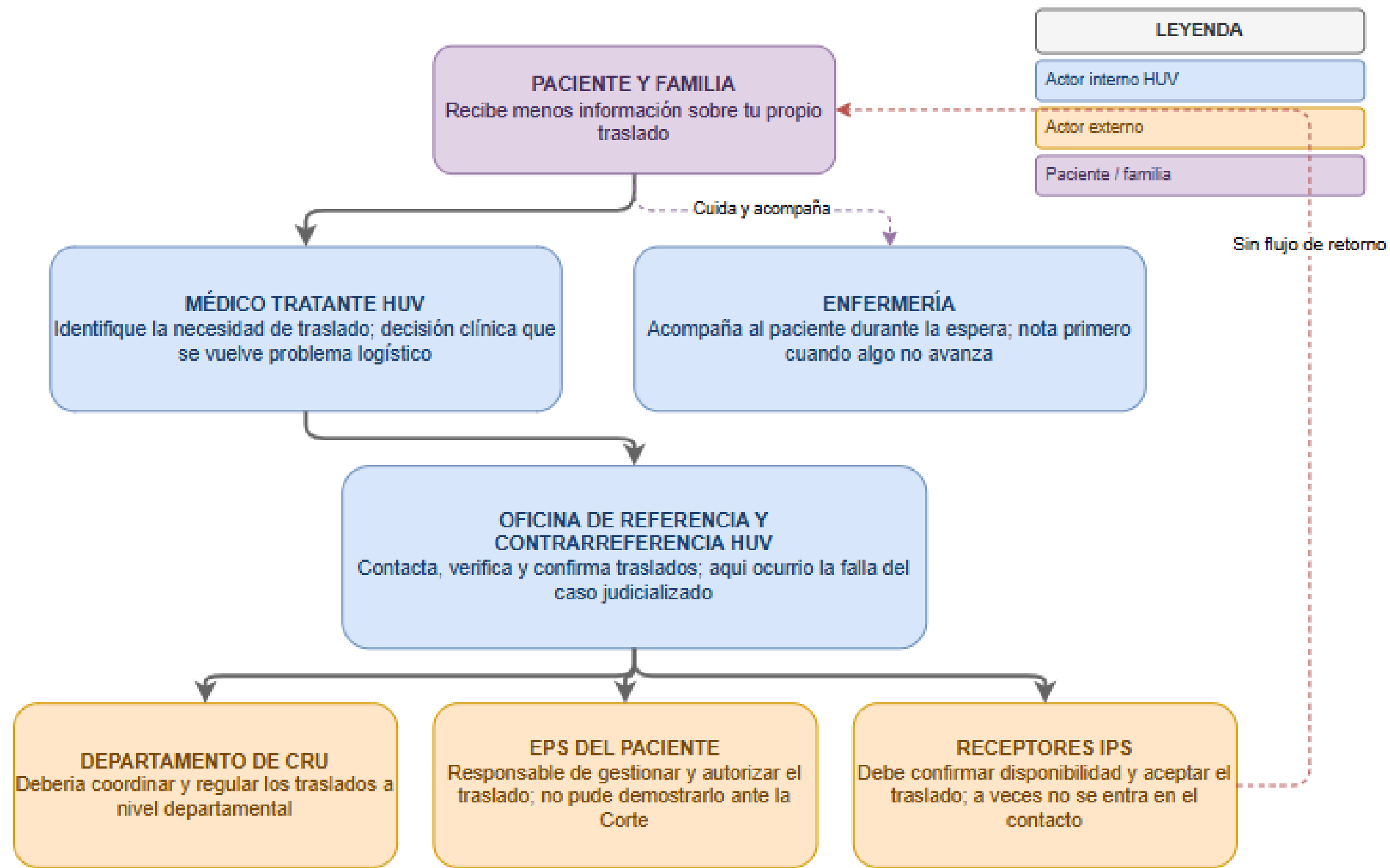
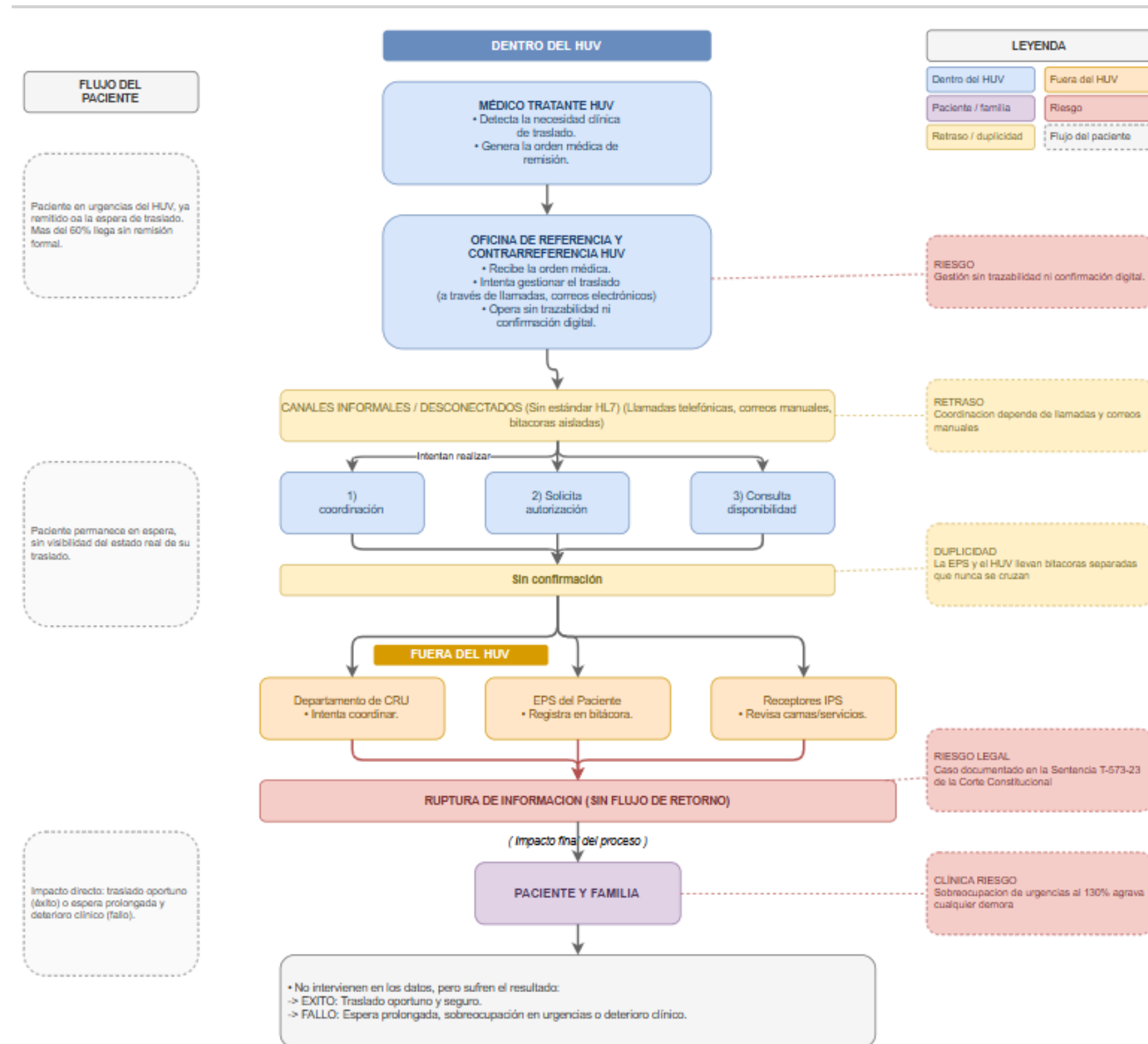


Diagrama proceso actual (AS-IS)



Por qué es un reto de Salud Digital

No es un problema de digitalizar una bitácora, es que la información no se integra entre instituciones. Los datos existen (bitácora de la EPS, registros del HUV) pero viven en mundos separados. Múltiples actores necesitan compartir una misma versión de la verdad sobre cada traslado.



Cuádruple Objetivo y Propuesta conceptual

Salud poblacional: fortalece toda la red del suroccidente.

Experiencia del paciente: visibilidad real del estado de su traslado.

Costos: menos reprocesos y menor exposición legal.

Personal de salud: decisiones basadas en información confirmada, no en llamadas dispersas.

Registrar cada gestión de traslado de forma única y visible para todas las partes: quién contactó, a quién, cuándo, con qué respuesta, y si existía convenio vigente. Esa información la usarían el médico, la oficina de referencia, el CRU, las EPS y el propio paciente.

Beneficio esperado: trazabilidad real, menos reprocesos, y una red que responde de forma coordinada y verificable.



Bibliografía

- Corte Constitucional de Colombia. (2023). Sentencia T-573 de 2023.
<https://www.corteconstitucional.gov.co/Relatoria/2023/T-573-23.htm>
- Occidente.co. (2026, 30 de junio). EPS adeudan \$700 mil millones al Hospital Universitario del Valle.
<https://occidente.co/regionales/valle-del-cauca/hospital-universitario-del-valle-huv-crisis-financiera-sobreocupacion-urgencias/>
- Instituto Departamental de Salud de Nariño. (s.f.). Informes de referencia y contrarreferencia. .
<https://www.idsn.gov.co/publicaciones/15154/informes-de-referencia-y-contrarreferencia/>
- Rendón, L. F., & Bejarano, M. (2005). Remisiones en el Valle del Cauca. Análisis y pautas para orientar la red de servicios. Colombia Médica, 36(1).
<https://colombiamedica.univalle.edu.co/index.php/comedica/article/download/327/1107?inline=1>
- CES Enfermería. (s.f.). Factores que prolongan el proceso de referencia en salud entre una institución hospitalaria y un asegurador. <https://revistas.ces.edu.co/index.php/enfermeria/article/view/5926>
- SciELO Venezuela. (2025). Políticas de referencia y contrarreferencia en salud pública: comparación entre niveles de atención en América Latina. https://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2665-01692025000400307



"El HUV no necesita una pantalla nueva, necesita que la información de cada traslado sea confiable para todos los que dependen de ella."

